

QUEMADURAS POR ALQUITRÁN

Alicia Rodríguez Rigden, Estefanía Robles Martín, María Nuria Álvarez Díez.

INTRODUCCIÓN.

Alquitrán y asfalto: El alquitrán se obtienen de carbón bituminoso; el asfalto se obtiene de petróleo crudo. Ambos se utilizan para pavimentar y para la construcción de tejados, para lo cual necesitan ser calentados a temperaturas altas (superiores a 140°C). Producen quemaduras al contactar con la piel y se enfrían rápidamente.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico no suele presentar dificultad, ya que generalmente el paciente conoce la fuente de la quemadura.

TRATAMIENTO

La actuación inicial en quemaduras pequeñas debe ser aplicar inmediatamente agua fría para favorecer el enfriado rápido. Si son áreas extensas, puede ser peligroso hacerlo más de 10 minutos porque puede producir hipotermia.

En urgencias se debe retirar el alquitrán o asfalto mediante disolventes orgánicos:

- Ungüento de polimixina-neomicina-bacitracina (Bacisporin®), que además ayuda a prevenir infecciones.
- Vaselina.
- Aceite de girasol.
- Aceite de oliva.
- Mantequilla.
- Aceite corporal.

No se deben utilizar agentes como keroseno, gasolina, alcohol o acetona, ya que no son eficaces y además producen daños en los tejidos sanos.

Pueden ser necesarias varias aplicaciones para retirar todo el producto.

Las quemaduras producidas por estos agentes no deben ser desbridados.

Para quemaduras pequeñas sin complicaciones, pueden recibir curas y seguimiento en atención primaria.

Para casos extensos o complicados: valoración por cirugía plástica.

BIBLIOGRAFÍA

- Kaushik S, Bird S. Topical chemical burns: Initial assessment and management. In: UpToDate [Internet]. Traub SJ, Bachur RG, Moreira ME, Gardiner MF (Ed). Waltham, MA. [Accessed on November 2019]. Available en: www.uptodate.com.
- Rice P, Orgill DP. Emergency care of moderate and severe thermal burns in adults. In: UpToDate [Internet]. Moreira ED (Ed). Waltham, MA. [Accessed on November 2019]. Available en: www.uptodate.com.
- Bose B, Tredget T. Treatment of hot tar burns. Can Med Assoc J. 1982;127(1):21-2.